



Dr. El Marto
Knie- und Sportverletzungen

OA Dr. med. univ. Shady El Marto WDM
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | Facharzt für Unfallchirurgie
Am Hof 11 Top 9 | 1010 Wien | Tel.: **+43 664 328 44 65**
ordination@dr-elmarto.at | www.dr-elmarto.at

Early Active Rehab

Ganzheitliche Rehabilitation · Medizinische Aufsicht

Sehr geehrte Patientin, Sehr geehrter Patient,

Nach einer Verletzung oder Operation zählt jeder Tag. Für ein optimales Behandlungsergebnis braucht es dabei mehr als nur Zeit: Entscheidend sind eine professionelle medizinische Betreuung, individuell abgestimmte Therapien und ein gezielter Trainingsaufbau unter fachkundiger Anleitung.

Genau dafür haben wir gemeinsam mit Experten aus Sportwissenschaft und Physiotherapie das **Konzept - Early Active Rehab** - entwickelt. In drei aufeinander abgestimmten Phasen begleiten wir Sie von der frühen Regeneration bis zur vollen Belastbarkeit mit einem persönlichen Therapie- und Trainingsplan unter medizinischer Aufsicht. Ziel ist nicht nur eine schnelle Rehabilitation, sondern auch die nachhaltige Prävention weiterer Verletzungen.

Unsere Ziele für Ihre Rehabilitation

Unser Konzept ermöglicht Ihnen eine ganzheitliche, an Ihre Bedürfnisse angepasste Rehabilitation unter einem Dach und unter **ständiger medizinischer und therapeutischer Kontrolle**.

DIE 4 PHASEN

Phase 1 – Diagnose & Behandlung

OA Dr. Shady El Marto +43 664 328 44 65

Phase 2 – Regenerative Medizin & Heilungsbeschleunigung

OA Dr. Shady El Marto +43 664 328 44 65

Phase 3 – Rehabilitation & Aufbau

Heilmassage +43 650 4426 076

Physiotherapie +43 650 3403 411 oder +43 690 1064 7645

Phase 4 – Performance & Prävention

Personal Health Coach +43 680 2427 900

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen und Terminwünschen jederzeit zur Verfügung.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Dr. El Marto
Knie- und Sportverletzungen

OA Dr. med. univ. Shady El Marto WDM
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | Facharzt für Unfallchirurgie
Am Hof 11 Top 9 | 1010 Wien | Tel.: +43 664 328 44 65
ordination@dr-elmarto.at | www.dr-elmarto.at

Early Active Rehab

Schneller wieder fit · Schneller zurück im Leben

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

je früher der Körper gezielt unterstützt wird, desto schneller können Heilungsprozesse einsetzen und desto rascher gelingt die Rückkehr in Alltag, Beruf und Sport.

Unser Konzept namens - **Early Active Rehab** - vereint vier gezielte Therapiemaßnahmen, zu einem hocheffektiven Regenerationssystem. Jede Anwendung greift gezielt in entscheidende Heilungsprozesse ein um Schwellungen zu reduzieren, Schmerzen zu lindern, die Geweberegeneration zu aktivieren und Ihre Belastbarkeit schneller wiederherzustellen. Das Ergebnis ist eine deutlich **verkürzte Rehabilitationszeit**, mehr Beweglichkeit und eine Rückkehr zu voller Leistungsfähigkeit oft bereits nach wenigen Wochen..

Vier Therapien. Ein Ziel: Ihre schnellste Genesung.

Early Active Rehab ist unser exklusives und in der Ordination entwickeltes Nachbehandlungskonzept. Es kombiniert **Kältekompressionstherapie, Magnetolithherapie, Vitamin-C-Infusionstherapie und extrakorporale Stoßwellentherapie**. Vier hocheffektive, nichtinvasive Verfahren, die in ihrer Kombination deutlich mehr bewirken als jedes einzelne davon allein.

KÄLTEKOMPRESSION

Game Ready – Kältekompression Direkt ab dem ersten Tag nach der OP; GR kombiniert gezielte Kühlung mit wechselndem Kompressionsdruck. Schwellungen werden aktiv reduziert

MAGNETOLITHERAPIE

Begleitend und nahezu schmerzfrei;
Hochfrequente Magnetfelder dringen tief ins Gewebe und aktivieren die Zellregeneration auf biologischer Ebene: Entzündungen klingen ab

VITAMIN-C INFUSION

Intravenös – Hochdosiertes Vitamin C ist sofort verfügbar für Wundheilung, Kollagenaufbau und ihr Immunsystem.

STOßWELLENTHERAPIE

Der Heilungsabschluss mit Tiefenwirkung;
Hochenergetische Stoßwellen aktivieren die Selbstheilungskräfte im Gewebe, lösen Verkalkungen, fördern die Durchblutung und beschleunigen den Gewebeumbau.

Warum Early Active Rehab?

Weil jede Phase genau dort ansetzt, wo der Körper gerade steht. Unser Therapieansatz begleitet jede Phase Ihrer Genesung für eine nachhaltige Wiederherstellung der Funktion. So verkürzen wir den Weg zurück in Ihren aktiven Alltag und den Sport oft innerhalb weniger Wochen.

Für weitere Informationen und Terminvereinbarung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Extrakorporale **Magnetolith-Therapie**

Tiefe Zellregeneration · Ambulant · Schmerzfrei

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die Magnetolith-Therapie (EMTT – Extrakorporale Magnetotransduktionstherapie) zählt zu den modernsten Entwicklungen der nichtinvasiven regenerativen Medizin im Bereich des Bewegungsapparates. Sie nutzt hochenergetische, hochfrequente Magnetimpulse, die tief in das Gewebe eindringen können, ohne Haut oder umliegende Strukturen zu belasten. Dadurch lassen sich biologische Heilungsprozesse gezielt stimulieren und das vollkommen berührungsfrei und nahezu schmerzfrei. EMTT wird heute insbesondere bei Gelenkbeschwerden, Sehnenreizungen, Muskelverletzungen, Rückenschmerzen, Arthrose sowie verzögerter Knochenheilung eingesetzt. Die Behandlung dauert nur wenige Minuten und kann problemlos in den Alltag integriert werden.

Wie wirkt die Magnetolith-Therapie auf Zellebene?

Auf zellulärer Ebene erzeugen die Magnetimpulse elektrische Mikrostimulationen im Gewebe. Diese aktivieren wichtige Signalwege innerhalb der Zellen, steigern die Durchblutung und fördern den natürlichen Zellstoffwechsel.

Entzündungsprozesse können reguliert, Schmerzrezeptoren beruhigt und regenerative Mechanismen gezielt angeregt werden. Gleichzeitig wird die Aktivität von Osteoblasten (knochenbildenden Zellen), Fibroblasten (Bindegewebszellen) und Sehnenzellen unterstützt, was die Kollagenbildung, Gewebestabilität und Knochenmineralisation verbessern kann.

Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen zudem positive Effekte auf Schmerzreduktion, Funktionsverbesserung und die Beschleunigung biologischer Heilungsprozesse.

IHRE VORTEILE

- › Nahezu vollständig schmerzfrei
- › Tiefe Gewebewirkung ohne Hautbelastung
- › Regeneration auf Zellebene – wissenschaftlich belegt
- › Entzündungshemmend & schmerzlindernd
- › Keine Einschränkungen nach der Behandlung

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Nach Operationen & Sportverletzungen
- › Schmerzen und Nervenreizungen im Rücken
- › Degenerative Gelenkerkrankungen & Arthrose
- › Gelenke nach Verletzungen & bei Knorpelschäden
- › Sehnenüberlastungssyndrome

BEHANDLUNGEN

6–8 Einheiten als Block

WIEDERHOLUNGEN

Alle 3–5 Tage · ca. 8–10 Min. pro Sitzung

Wussten Sie schon – Dass die Kombination aus der Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie besonders wirksam ist? Bereits 2018 zeigte eine prospektive, randomisierte Studie, dass die Kombination aus Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie einer Einzeltherapie überlegen ist.

** Magnetoliththerapie nicht geeignet bei Herzschrittmacher, Defibrillator, Hörgeräten, nicht MR-tauglichen Implantaten.*

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

Nichtinvasiv · Ambulant · Zurück zum Sport

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die Stoßwellentherapie setzt hochenergetische Schallwellen gezielt im Gewebe ein – ohne Operation, ohne Narkose, ohne Ausfallzeiten. Was ursprünglich aus der Nierensteintherapie stammt, hat sich in der Orthopädie und Sportmedizin zu einem der wirksamsten nichtinvasiven Behandlungsverfahren entwickelt. Besonders nach Bandrekonstruktionen und bei Knorpelschädigungen lässt sich das Behandlungsergebnis durch ESWT gravierend verbessern und die Rückkehr zum Sport deutlich beschleunigen.

Wie wirkt die Stoßwellentherapie?

Die Wirkung basiert auf präzise dosierten Druckwellen, die im behandelten Bereich biologische Reparaturmechanismen auslösen. Über den Prozess der sogenannten Mechanotransduktion reagieren Zellen auf den physikalischen Impuls mit einer verstärkten Produktion regenerativer Botenstoffe. Dadurch wird die lokale Durchblutung verbessert, der Zellstoffwechsel aktiviert und die Neubildung von Gefäßen sowie gesundem Gewebe angeregt. Gleichzeitig können chronische Entzündungsprozesse reguliert, Verkalkungen gelöst und Schmerzsignale reduziert werden. Wissenschaftliche Studien belegen insbesondere bei Sehnentzündungen, Arthrose und knöchernen Heilungsstörungen eine hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit.

IHRE VORTEILE

- › Keine Operation, kein Narkoserisiko
- › Ambulant – keine Ausfallzeiten
- › Aktivierung körpereigener Heilungsprozesse
- › Nachhaltige Schmerzreduktion
- › Schnellere Rückkehr zum Sport
- › Individuell auf Ihr Schmerzempfinden eingestellt
- › Wirksam auch dort, wo andere Therapien versagen

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Muskuloskelettale Erkrankungen
- › Degenerative Erkrankungen (Bandscheibenvorfall, Spondylarthrose)
- › Arthrose (Knie, Hüfte, Hände, Schulter, Ellenbogen)
- › Sehnenüberlastungssyndrome & chronische Entzündungen
- › Sportverletzungen & nach Operationen (Kreuzband, Knorpel)
- › Muskelverspannungen, Radikulopathien & Lumbalgie

BEHANDLUNGEN

3-5 Einheiten als Block

WIEDERHOLUNGEN

Alle 10–14 Tage · ca. 3–5 Min. pro Sitzung

ESWT & Magnetolith-Therapie im intelligent kombinierten Therapiekonzept



Vitamin C Infusionstherapie

Schneller fit · Schneller zurück im Leben

**Sehr geehrter Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

wir erweitern unser Therapieangebot um die **Vitamin-C-Infusionstherapie**, eine gezielte Möglichkeit, den Körper genau dann zu unterstützen, wenn er besonders gefordert ist.

Nach einer Operation läuft die Regeneration auf Hochtouren: Gewebe muss sich erneuern, Wunden schließen, das Immunsystem stabil bleiben. Vitamin C ist dabei ein **zentraler Baustein**. Es unterstützt die Kollagenbildung für stabiles Gewebe, trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei und begleitet den natürlichen Heilungsprozess. Auch vorbeugend, etwa bei erhöhter körperlicher Belastung, ist eine optimale Versorgung sinnvoll.

Der entscheidende Unterschied in der Vitamin-C-Versorgung

Oral aufgenommenes Vitamin C ist durch die begrenzte Aufnahmefähigkeit des Darms eingeschränkt. Lediglich ca. 10–20 % erreichen tatsächlich den Blutkreislauf. Eine intravenöse Verabreichung umgeht diese natürliche Barriere: Hochdosiertes Vitamin C gelangt direkt in Ihre Blutbahn und steht dem Körper nahezu vollständig zur Verfügung. **Effizient, gezielt und ohne unnötige Verluste.**

IHRE VORTEILE

- › Direkte Aufnahme über die Blutbahn
- › Deutlich höhere Dosierung möglich
- › Sofortige Versorgung des Körpers
- › Umgehung des Magen-Darm-Trakts
- › Minimaler Vitaminverlust

NACH OPERATIONEN

- › Beschleunigte Wundheilung
- › Reduktion von Entzündungen
- › Weniger postoperative Schmerzen
- › Stärkung des Immunsystems
- › Schnellere Erholung & weniger Komplikationen

DAUER

ca. 30 Minuten pro Infusion

WIEDERHOLUNGEN

4–5 Infusionen über 4–6 Wochen

Vor jeder Behandlung nehmen wir uns Zeit für Sie: In einem ausführlichen Vorgespräch klären wir Ihre individuelle Situation und informieren Sie transparent über die Therapie.

Die Vitamin-C-Infusion ist in der Regel **sehr gut verträglich**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen und Terminwünschen jederzeit zur Verfügung.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Game Ready – Kältekompressionstherapie

Schneller erholen · Schneller zurück im Leben

**Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

um ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, ist nach einer Operation oder Verletzung eine professionelle Nachbehandlung entscheidend. Schwellungen, die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen, gehören dabei zu den häufigsten Herausforderungen.

Die Kälte- und Kompressionssterapie reduziert Schwellungen gezielt, fördert den Lymphabfluss und lindert Schmerzen spürbar – für eine rasche Schmerzlinderung und verbesserte Beweglichkeit.

Warum Kälte und Kompression so wirksam sind

Nach einer Operation oder Verletzung sind Schwellung und Schmerz natürliche Körperreaktionen – sie verlangsamen jedoch die Heilung. Kälte verengt die Gefäße und reduziert Entzündungsreize, während Kompression Flüssigkeitsansammlungen aktiv abtransportiert.

Game Ready vereint beide Effekte in einem System: gleichzeitige Kühlung und wechselnder Kompressionsdruck – **effizient, angenehm** und **ohne Nebenwirkungen**.

IHRE VORTEILE

- › Gezielte Reduktion von Schwellungen
- › Förderung des Lymphabflusses
- › Schnelle und spürbare Schmerzlinderung
- › Verbesserte Beweglichkeit bereits nach wenigen Anwendungen
- › Von Patientinnen und Patienten als sehr angenehm empfunden

NACH OPERATIONEN

- › Postoperative Schmerzreduktion & Entwässerung
- › Schnellere Rückkehr zur vollen Beweglichkeit

DAUER

ca. 10 Minuten pro Anwendung

WIEDERHOLUNGEN

3-5 Anwendungen alle 3-5 Tage

Damit Ihr Aufwand so gering wie möglich ausfällt, bieten wir in unserer Ordination eine ganzheitliche Betreuung – damit Sie sich so einfach wie möglich regenerieren können.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



ACP-Eigenbluttherapie & Hyaluronsäure

ACP – Autologes Konditioniertes Plasma

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die Natur hat dem menschlichen Körper bemerkenswerte Selbstheilungskräfte mitgegeben. ACP – die Eigenbluttherapie mit autologem konditioniertem Plasma – macht genau diese Kräfte gezielt nutzbar. Aus einer kleinen Menge Ihres eigenen Blutes wird ein hochkonzentriertes Plasma gewonnen, das in Kombination mit Hyaluronsäure direkt ins Gelenk injiziert wird. Das Ergebnis: weniger Schmerz, mehr Beweglichkeit, geschützter Knorpel.

Was ist ACP – und wie wirkt es auf Zellebene?

ACP ist eine Form des thrombozytenreichen Plasmas (PRP), die durch ein spezielles Zentrifugationsverfahren aus dem eigenen Blut gewonnen wird. Der entscheidende Vorteil liegt in der speziellen Aufbereitung des Plasmas: Es wird leukozytenarm gewonnen – also mit deutlich weniger weißen Blutkörperchen, die Entzündungsreaktionen fördern können. Gleichzeitig enthält es eine hohe Konzentration wertvoller Wachstumsfaktoren. Diese biologischen Signalstoffe unterstützen gezielt die Knorpelzellen, regen die Bildung von Kollagen an, reduzieren entzündliche Prozesse im Gelenk und können den weiteren Knorpelabbau verlangsamen.

Da ACP aus Ihrem eigenen Blut gewonnen wird, sind allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten nahezu ausgeschlossen. Die Kombination mit Hyaluronsäure verstärkt die Wirkung zusätzlich: Während ACP die Regeneration biologisch anstößt, stellt Hyaluronsäure die Gelenksschmiere wieder her und schafft das ideale mechanische Milieu für die Heilung.

IHRE VORTEILE

- › 100 % körpereigen – kein Fremdmaterial
- › Optimal verträglich
- › Regenerativ – nicht nur symptomlindernd
- › Knorpelschutz & Wiederherstellung der Gelenksschmiere
- › Kein Kortison, keine chemischen Substanzen
- › Ambulant – keine Ausfallzeiten
- › Überlegen gegenüber Kortison in Langzeitstudien

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Kniegelenksarthrose (alle Schweregrade)
- › Nachbehandlung nach Kreuzbandrekonstruktion
- › Hüft-, Schulter- & Sprunggelenksarthrose
- › Sehnenerkrankungen & Knorpelschäden
- › Nachbehandlung nach Kreuzbandrekonstruktion
- › Sportschäden & chronische Gelenküberlastungen

Was ist Hyaluronsäure ? Das ist ein körpereigener Bestandteil jedes gesunden Gelenks. Bei Arthrose sinkt ihre Konzentration – vor allem bei früh- bis mittelgradiger Arthrose. Die gezielte Injektion hochmolekularer HA wirkt auf mehreren Ebenen gleichzeitig: **mechanisch, biologisch knorpelprotektiv**



Arthroskopie des **Schultergelenks**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Schultergelenks.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

Sofortmaßnahmen in den ersten Tagen

Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten**, nicht direkt auf die Haut) sowie Durchführung isometrischer Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Verbandsanordnung bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigegeführten Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit
- › **Nahtentfernung** 10–14 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Schultergelenks: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung nach **Arthroskopie** des **Schultergelenks**

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine Arthroskopie des Schultergelenks durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Bitte verwenden Sie, wenn nicht anders kommuniziert, die ersten **2 Wochen** den angelegten Verband. Zum Duschen kann die Verbandsanordnung selbstverständlich abgenommen werden.

Ihr Rehabilitationsplan im Überblick

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Die Empfehlungen basieren auf der aktuellen Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses.

AB DER 1. WOCHE

Beginn mit der **Magnetolith-Therapie (EMTT)** – ca. 6–8 Einheiten alle 3–5 Tage in unserer Ordination sowie der **Vitamin-C Infusion** für 4-6 Einheiten über 4-6 Wochen

Zu Hause selbständige Anwendung von Coolpacks. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCHE

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellen-Therapie (ESWT)** – 5 Einheiten im 10–14 Tagesabstand in der Ordination.

Die **physikalische Therapie** kann nun begonnen werden.

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung und zum Schutz des Gelenkknorpels sowie zur raschen Wiederherstellung der Gelenkschmiere.

INFILTRATIONSOPTIONEN

- › **ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure** - bei dieser Maßnahme wird körpereigenes, wachstumsfaktorreiches Plasma mit Hyaluronsäure gemischt und in Gelenke gespritzt wird. Diese Kombination wirkt synergistisch: Die Hyaluronsäure schmiert das Gelenk, während ACP-PRP Entzündungen hemmt und die Regeneration von Knorpel, Sehnen und Bändern fördert
- › **Isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Arthroskopisch assistierter **vorderer Kreuzbandersatz**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopisch assistierter vorderer Kreuzbandersatz.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigegefügt Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei Ersatz des vorderen Kreuzbandes

Wochen 1–2 · Sofortmaßnahmen & erste Therapieschritte

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen ist ein arthroskopisch assistierter Ersatz des vorderen Kreuzbandes durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Generell gilt: aktives Strecken des Beines in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** des Beines stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie bis zur Nahtentfernung (ca. 10–14 Tage nach OP) unterstützend die Krücken und peilen Sie eine **Teilbelastung mit halbem Körpergewicht** an.

Das Tragen der **Kniegelenksorthese in Einstellung F 60 Grad** ist bis zur Nahtentfernung **Tag und Nacht** empfohlen. Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden. Die Gesamttagedauer der Orthese beträgt **6 Wochen**.

AB DER 1. WOCH E

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit Kältekompression, Magnetolith-Therapie und Vitamin-C-Infusionen begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiteten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen.

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines sowie isometrische Spannungsübungen mit aktivem Strecken im Kniegelenk. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH E

Starten sie mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung.

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie ESWT** (5 Einheiten alle 10–14 Tage in der Ordination).

Die **Kniegelenksorthese** kann am **Ende der 2. Woche** auf **F 90 Grad** umgestellt werden.

Fortsetzung auf Seite 2 – Rehabilitation ab Woche 4 bis zur Sportfreigabe nach 9–12 Monaten



Nachbehandlung bei Ersatz des **vorderen Kreuzbandes**

Wochen 4–52 · Sport & langfristige Rehabilitation

NACH 4 WOCHEN

Die Anwendung der **Infiltrationen** zur Optimierung der Einheilung des vorderen Kreuzbandes sowie zum Schutz des Gelenkknorpels und zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere.

Verfügbare Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure sowie isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Vorsichtiges **Ergometerfahren** bei Beugung **ab 100 Grad** (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel).

Die Orthese kann konsequent weggelassen werden.

NACH 8 WOCHEN

Steigen Sie mit Nordic Walking, Schwimmen und Outdoor-Radfahren sanft wieder ein.

Aquajogging und **angeleitetes Kraft-Stabilitäts-Training** durch **unsere Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen** runden das Programm ab, um Ihren Genesungsprozess optimal zu unterstützen.

NACH 12 WOCHEN

Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

NACH 9 BIS 12 MONATEN

Behutsamer Satrt mit **Kontaktssport** (Kampfsportarten) sowie Stop-and-Go-Sportarten (Fußball, Tennis, Squash, Skifahren etc.) **nach Freigabe durch OA Dr. El Marto.**

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopie des Sprunggelenks

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Sprunggelenks**. Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigelegten Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Sprunggelenks: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung nach Arthroskopie des Sprunggelenks

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine **Arthroskopie des Sprunggelenks** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend zur Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **5–7 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden. Bewegungsübungen für das obere Sprunggelenk können **ab dem ersten Tag nach der OP** durchgeführt werden.

AB DER 1. WOCH

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen. Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

AB DER 2. WOCH

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** in der Ordination. Die physikalische Therapie kann nun begonnen werden.

AB DER 4. WOCH

Um die Gelenksschmiere rasch wiederherzustellen, empfehlen sich **Infiltrationen**, die gleichzeitig den Knorpel schützen. **Optionen:** ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure oder isolierte Infiltration mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren, Aquajogging sowie muskelstabilisierenden Übungen unter **Anleitung der Physiotherapeut:innen**, ergänzt durch lockeres Laufen sowie einen schrittweisen Aufbau von Kraft- und Stabilisationsübungen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.



Arthroskopisch assistierte **MPFL Rekonstruktion**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopisch assistierte MPFL Rekonstruktion.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie isometrische Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigegefügt Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung bei **MPFL Rekonstruktion**

Wochen 1–2 · Sofortmaßnahmen & erste Therapieschritte

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen ist ein **arthroskopisch assistierter Ersatz des MPFL Apparates** durchgeführt worden.

Folgende Empfehlungen sind als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie bis zur Nahtentfernung (ca. 10–14 Tage nach OP) unterstützend die Krücken und peilen Sie eine **Teilbelastung mit halbem Körpergewicht** an.

Tragen der **Kniegelenksorthese F 30 Grad** bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht empfohlen (zum Duschen abnehmbar). Gesamttragedauer: **6 Wochen**.

AB DER 1. WOCH

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiteten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen.

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines sowie isometrische Spannungsübungen mit aktivem Strecken im Kniegelenk. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH

Starten sie mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung.

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie ESWT** (5 Einheiten alle 10–14 Tage in der Ordination).

Die **Kniegelenksorthese** kann am **Ende der 2. Woche** auf **F 90 Grad** umgestellt werden.

Fortsetzung auf Seite 2 – Rehabilitation ab Woche 4 bis zur Sportfreigabe nach 9–12 Monaten



Nachbehandlung bei **MPFL** Rekonstruktion

Wochen 4–52 · Sport & langfristige Rehabilitation

NACH 4 WOCHEN

Die Anwendung der **Infiltrationen** zur Optimierung der Einheilung des vorderen Kreuzbandes sowie zum Schutz des Gelenkknorpels und zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere.

Verfügbare Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure sowie isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit vorsichtigem **Ergometerfahren** bei Beugung ab 100 Grad (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel). Die Orthese kann konsequent weggelassen werden.

NACH 8 WOCHEN

Steigen Sie mit Nordic Walking, Schwimmen und Outdoor-Radfahren sanft wieder ein. Aquajogging und **angeleitetes** Kraft-Stabilitäts-Training durch **unsere Physiotherapeut:innen** runden das Programm ab, um Ihren Genesungsprozess optimal zu unterstützen.

NACH 12 WOCHEN

Behutsamer Einstieg mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeut:innen

NACH 9 BIS 12 MONATEN

Vorsichtiger Beginn mit **Kontaktsport** (Kampfsportarten) sowie Stop-and-Go-Sportarten (Fußball, Tennis, Squash, Skifahren etc.) **nach Freigabe** durch **OA Dr. El Marto**.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung bei **Achillessehnenrekonstruktion**

Combining der Achillessehne mit Abtragung von Exostosen

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

Bei Ihnen ist eine **Rekonstruktion der Achillessehne** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **14 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Ihnen wurde ein **Aircastwalker mit 2–3 Keilen** angepasst. Dieser sollte für **6 Wochen, Tag und Nacht** getragen werden. Es wird empfohlen, den **Aircastwalker** regelmäßig zu öffnen und den Fuß zu lüften.

1. WOCH E

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen. Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

2. WOCH E

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** – 5 Behandlungen in der Ordination.

NACH 6 WOCH EN

Abnahme des Aircastwalkers und Beginn mit **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeut:innen.

AIRCSTWALKER – HINWEIS

Gesamttragedauer: **6 Wochen Tag und Nacht**. Regelmäßiges Öffnen und Lüften des Fußes empfohlen. 2–3 Keile bleiben bis zur Abnahme eingelegt.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Endergebnisses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopie des Kniegelenks mit Microfracturing oder Autocart

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Kniegelenks mit Microfracturing oder Autocart**. Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht**.

Die Motorschiene soll anfangs **täglich zwei Mal** mit der **Einstellung 0-60 °** angewendet werden. Dies kann von Woche zu Woche nach Rücksprache gesteigert werden.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigegefügt Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Konsequente Entlastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung nach Arthroskopie des Kniegelenks mit Microfacturing oder Autocart

Wochen 1–2 · Therapieschritte · Sport ab Woche 6

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine **Arthroskopie des Kniegelenks** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend zur Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **4 Wochen** unterstützend **die Krücken** mit konsequenter Entlastung.

Nach den ersten 48 Stunden in **absoluter Streckstellung** soll das Tragen der **Kniegelenksorthese** in der **Einstellung F 30 Grad** bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht erfolgen.

AB DER 1. WOCH

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen.

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

Die Motorschiene kann ab dem zweiten Tag nach der OP mit der **Einstellung 0-60 Grad** angewendet werden.

AB DER 2. WOCH

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** in der Ordination. Die physikalische Therapie kann nun begonnen werden. Hier wird die Schiene auf **0-60 Grad** umgestellt.

AB DER 4. WOCH

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung und zum Schutz des Gelenkknorpels sowie zur raschen Wiederherstellung der Gelenkschmiere. **Optionen:** ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure oder isolierte Infiltration mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure. Es kann vorsichtig mit Teilbelastung mit 20 kg Körpergewicht begonnen werden. Die Schiene auf **0-90 Grad** einstellen.

NACH 6 WOCHEN

Start mit **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeut:innen

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.



Stabilisierung der Syndesmose – **Syndesmosenrepair**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Stabilisierung der Syndesmose – Syndesmosenrepair**. Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihren **Aircastwalker**, der Ihnen im Spital angepasst wurde, konsequent.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigelegten Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und halbem Körpergewicht für 2 Wochen
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei **Syndesmosenrepair**

Rekonstruktion & Stabilisierung der Syndesmose

Rehabilitationsplan

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen ist eine **Rekonstruktion und Stabilisierung der Syndesmose** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **14 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Der **Aircastwalker** sollte für **6 Wochen Tag und Nacht** getragen werden. Es wird empfohlen, den Aircastwalker regelmäßig zu öffnen und den Fuß zu lüften.

1. WOCH E

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen.

Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

2. WOCH E

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** – 5 Einheiten alle 10–14 Tage in unserer Ordination.

NACH 6 WOCH E

Abnahme des Aircastwalkers und Beginn mit muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen unter Anleitung des Physiotherapeuten/Innen.

AIRCASTWALKER – HINWEIS

Gesamttragedauer: **6 Wochen Tag und Nacht**. Regelmäßiges Öffnen und Lüften des Fußes empfohlen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und richten sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Endergebnisses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopie des Kniegelenks

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Kniegelenks.**

Hier sind die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie isometrische Spannungsübungen der Muskulatur.
Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle konsequent Tag und Nacht.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Zur Förderung Ihrer Regeneration setzen wir auf unser bewährtes **Early Active Rehab** -Konzept. Durch das Zusammenspiel von Kältekompression, Vitamin-C-Infusionen, Stoßwellen- und Magnetolith-Therapie erzielen wir die bestmögliche Heilungsbeschleunigung. Nähere Informationen finden Sie im beigefügten Material.
- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie**
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und halbem Körpergewicht bis zur Nahtentfernung
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung nach **Arthroskopie des Kniegelenks**

Rehabilitationsplan · Wochen 1–6

Liebe Patientin, Lieber Patient,

bei Ihnen ist eine **Arthroskopie des Kniegelenks** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit Hochlagerung und Kühlung stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten 5–7 Tage unterstützend die Krücken (Teilbelastung mit halbem Körpergewicht). Kniegelenksorthese F 90 Grad bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht empfohlen. Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden.

AB DER 1. WOCHE

Zur Unterstützung der Heilung empfehlen wir unser **Early Active Rehab** Programm.

Bereits ab der ersten Woche kann mit **Kältekompression, Magnetolith-Therapie** und **Vitamin-C-Infusionen** begonnen werden. Die einzelnen Maßnahmen fördern die Regeneration und den begleiten bestmöglich den Heilungsverlauf. Nähere Informationen finden Sie in den beiliegenden Unterlagen. Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCHE

Beginn mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung. Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit **Stoßwellentherapie** – 5 Einheiten alle 10–14 Tage in unserer Ordination.

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung, Schutz des Gelenkknorpels und Wiederherstellung der Gelenksschmiere (ACP-PRP + Hyaluronsäure oder isoliert hochkonzentrierte Hyaluronsäure). Zusätzlich vorsichtiges Ergometerfahren (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel).

NACH 6 WOCHEN

Start mit Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren im Freien, Aquajogging und muskelstabilisierenden Übungen unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Zusätzlich Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeut:innen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.



Dr. El Marto
Knie- und Sportverletzungen



OA Dr. med. univ. Shady El Marto WDM

Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | Facharzt für Unfallchirurgie

Am Hof 11 Top 9 | 1010 Wien | Tel.: **+43 664 328 44 65**

ordination@dr-elmarto.at | www.dr-elmarto.at
